



FORUM DE CANCEROLOGIE DE ROCHE

TRAITEMENT DU CANCER DU SEIN HER2 + METASTATIQUE



www.forumcancerologie-roche.com



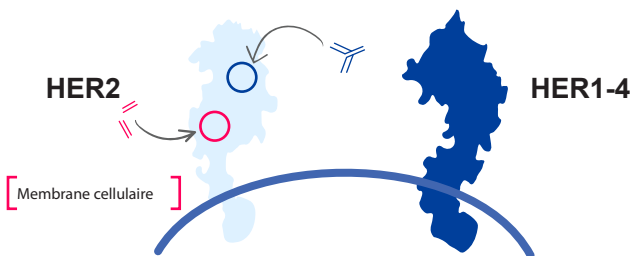
Roche

PERTUZUMAB ET TRASTUZUMAB SONT 2 AGENTS BLOQUEURS DES RECEPTEURS HER2^{1,2}

PERJETA ET HERCEPTIN se lient à des epitopes HER2 distincts avec un mécanisme d'action complémentaire³

TRASTUZUMAB
se lie au sous-domaine IV
et inhibe la signalisation en aval

PERTUZUMAB
se lie à un domaine II spécifique
et inhibe la dimérisation activée
par le ligand



L'association **PERTUZUMAB** - **TRASTUZUMAB** offre un blocage anti-HER2 plus complet que l'un ou l'autre des agents utilisés seuls⁴

NCCN

Les recommandations du NCCN établissent la combinaison **PERTUZUMAB & TRASTUZUMAB** comme le traitement de référence en 1^{ère} ligne métastatique des cancers du sein HER2+⁵

TRAITEMENT DE PREMIERE LIGNE

PERTUZUMAB et TRASTUZUMAB



DOCETAXEL OU PACLITAXEL

AUTRES OPTIONS

- Tucatinib + trastuzumab + capecitabine
- Ado-trastuzumab emtansine (T-DM1)
- Fam-trastuzumab deruxtecan-nxkin
- Trastuzumab + paclitaxel ± carboplatin
- Trastuzumab + docetaxel
- Trastuzumab + vinorelbine
- Trastuzumab + capecitabine
- Lapatinib + capecitabine
- Trastuzumab + lapatinib (sans chimiothérapie)
- Neratinib + capecitabine

1. RCP PERJETA – Aout 2020

2. RCP Herceptin® SC. Aout 2021

3. Matthew C. Franklin, Insights into ErbB signaling from the structure of the ErbB2-pertuzumab complex - CANCER CELL : APRIL 2004 · VOL. 5

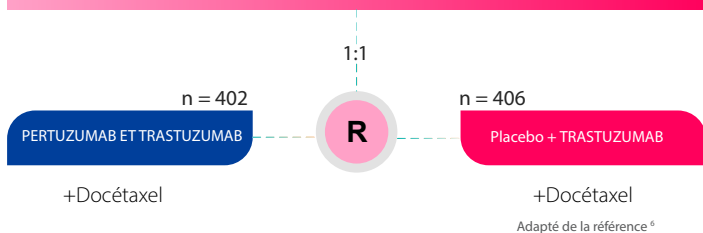
4. Rita Nahta. The HER2 targeting antibodies Trastuzumab and Perjeta synergistically inhibit the survival of breast cancer cells. Cancer research 64; 2343-2346; April 1, 2004

5. NCCN Breast Cancer Guidelines. Version 6, 2020

ETUDE CLEOPATRA

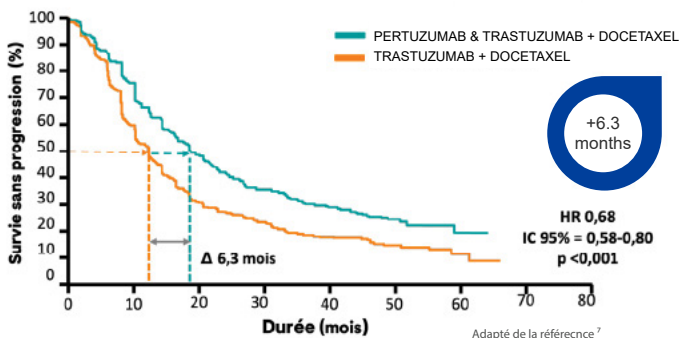
PROTOCOLE DE L'ETUDE⁶

Patientes atteintes d'un cancer métastatique HER2+ confirmé de manière centralisée (N = 808)



- **Critère d'évaluation primaire:** Survie sans progression
- **Critères d'évaluation secondaires:** Survie sans progression, Survie Globale, taux de réponse globale, profil de tolérance

DONNEES SUR LA SURVIE SANS PROGRESSION⁷



PERTUZUMAB ET TRASTUZUMAB + DOCETAXEL a augmenté la survie médiane sans progression de 6,3 mois par rapport au TRASTUZUMAB + DOCETAXEL

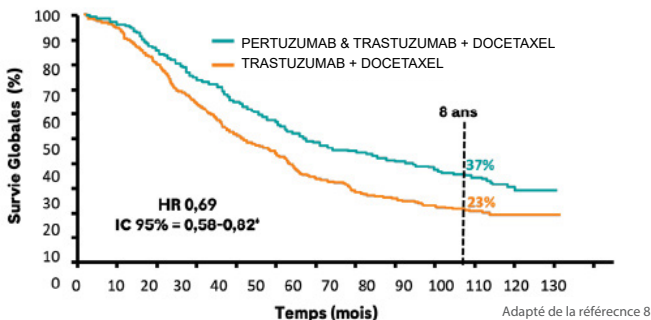


32%

De réduction du risque de progression de la maladie

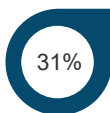
ETUDE CLEOPATRA

DONNEES SUR LA SURVIE GLOBALE⁸



Le taux de survie globale à la fin de l'étude était de 37% dans le groupe PERTUZUMAB ET TRASTUZUMAB + DOCETAXEL, avec un suivi médian de 99,9 mois⁸

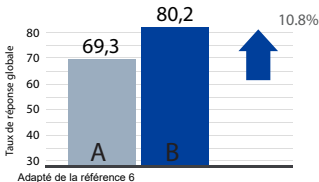
Bénéfice en terme de survie sans précédent après plus de 8 ans avec PERTUZUMAB ET TRASTUZUMAB + docétaxel pour les cancers du sein métastatiques HER2+



De réduction du risque de décès

DONNEES SUR LA REPONSE GLOBALE^{6,7}

REPONSE OBJECTIVE⁶

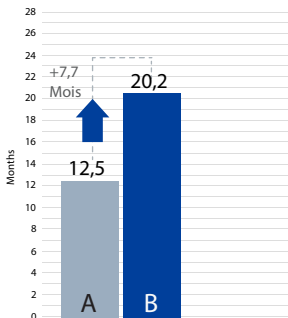


Le taux de réponse globale dépasse 80% avec PERTUZUMAB ET TRASTUZUMAB+DOCETAXEL⁶

Placebo + Trastuzumab + Docétaxel A

PERTUZUMAB ET TRASTUZUMAB + Docétaxel B

DUREE MEDIANE DE LA REPONSE⁷



La durée médiane de la réponse est presque doublée avec PERTUZAMAB ET TRASTUZUMAB+Docétaxel⁷

12,5 mois
95% CI (10,0-15,0)

Placebo + Trastuzumab + Docétaxel A

20,2 mois
95% CI 16,0-24,0)

PERTUZUMAB ET TRASTUZUMAB + Docétaxel B

Adapté de la référence 7

6. Baselga J, et al. N Engl J Med 2012; 366:109-119.

7. Swain SM, et al. N Engl J Med 2015 ; 372:724-734

8. Swain SM, et al. Lancet Oncol 2020.



ETUDE CLEOPATRA

PROFIL DE SECURITE CARDIAQUE ET TOLERANCE GLOBALE^{9,10}

Patientes présentant une diminution de la FEVG* de $\geq 10\%$ par rapport à la valeur de référence et jusqu'à $< 50\%$ ⁹

Patientes présentant une diminution de la FEVG* de $\geq 10\%$ par rapport à la valeur de référence et jusqu'à $< 50\%$ ¹⁰



Adapté de la référence 9

DURANT LE TRAITEMENT



Adapté de la référence 10

APRÈS LE TRAITEMENT

L'association PERTUZUMAB ET TRASTUZUMAB + DOCETAXEL (PHD) a un profil de sécurité cardiaque similaire au Trastuzumab + DOCETAXEL (HD) avant et après le traitement^{9,10}

La tolérance globale a été similaire entre les 2 groupes évalués en terme de fréquence, de sévérité, et de spécificité¹⁰.

9. Swain SM, et al. Lancet Oncol 2013; 14:461-471.

10. Supplement to: Swain SM, Baselga J, Kim S-B, et al. Pertuzumab, trastuzumab, and docetaxel in HER2-positive metastatic breast cancer. N Engl J Med 2015;372:724-34. DOI: 10.1056/NEJMoa1413513

Pour toute déclaration d'événements indésirables merci d'envoyer un mail à Roche Côte d'Ivoire Sarl au global.irt_sahubtcs@roche.com ou de téléphoner au +225 27 22 48 23 55

Pour toute demande d'information médicale merci d'envoyer un mail à westafrica.medinfo@roche.com ou de téléphoner au +225 27 22 48 23 55.

ROCHE Côte d'Ivoire SARL

Ivoire Trade Center, Cocody les ambassades Angle de la rue Hassan 2 et de la rue Booker Washington, Bâtiment D 1er étage

18 BP 2377 Abidjan 18, Côte d'Ivoire

Tél : +225 27 22 48 23 55

M-CI-00000279